

LAPORAN ANALISIS KLINIS

AI Doctor — Clinical Decision Support System

Tanggal: 18 June 2026, 11:16

1. Identitas Pasien

Nama : Dek Alif
Umur / Gender : 4 tahun / Laki-laki
Berat / Tinggi : 15.0 kg / 100.0 cm
No. RM : RM-016

2. Anamnesis & Pemeriksaan

Keluhan Utama: Kulit di lipatan siku kiri-kanan dan lipatan lutut gatal-gatal hebat serta kemerahan sampai luka karena sering digaruk.

Gejala Tambahan: Anak rewel terutama di malam hari karena gatal tidak tertahankan, kulit di area lipatan siku terasa sangat kering, kasar, dan bersisik.

Tanda Vital: 96x/m, Suhu: 36.7 C, RR: 22x/m

Hasil Laboratorium: -

Alergi: Riwayat alergi susu sapi saat bayi.

Catatan Bebas Dokter / Keterangan Tambahan:

Tampak plak eritematosa (bercak kemerahan) simetris disertai ekskoriasi (bekas garukan) pada fossa cubiti dextra et sinistra.

3. Riwayat Konsultasi Interaktif

[Dokter] "AI, obat kortikosteroid topikal (salep) potensi kekuatan berapa yang paling aman untuk anak usia 4 tahun dengan berat 15 kg?"

[AI] **Analisis:** Kemungkinan diagnosis utama adalah dermatitis atopik pada anak, ditunjang oleh gatal hebat kronik-kambuhan >6 bulan, distribusi khas di lipatan siku dan lutut, kulit sangat kering/bersisik, ekskoriasi, serta riwayat atopi keluarga (ibu asma). Diagnosis banding yang perlu dipertimbangkan adalah dermatitis kontak alergik/iritan, skabies bila gatal malam sangat dominan dan ada lesi pada sela jari/anggota keluarga ikut gatal, serta impetiginisasi sekunder bila terdapat krusta madu, nyeri, atau cairan. Untuk anak usia 4 tahun, area fleksural umumnya paling aman menggunakan kortikosteroid topikal potensi rendah hingga sedang; mulai dari potensi rendah, dan bila flare sedang dapat dipertimbangkan potensi sedang jangka pendek dengan pemantauan ketat. **Pertanyaan lanjutan:** Apakah ada anggota keluarga serumah yang juga mengalami gatal, terutama malam hari, atau ada lesi di sela jari/pergelangan tangan? | Apakah ruam juga muncul di wajah, leher, badan, atau bokong, dan apakah pernah keluar cairan, bernanah, atau berkrusta kuning? | Sabun, deterjen, lotion, pakaian, makanan, atau kondisi tertentu apa yang tampak memicu atau memperberat keluhan? **Status data:** Data cukup kuat untuk mengarah ke dermatitis atopik, tetapi masih perlu anamnesis pencetus, pemeriksaan distribusi lesi lebih lengkap, dan penilaian ada tidaknya infeksi sekunder atau skabies untuk menegaskan diagnosis kerja dengan lebih pasti.

4. Hasil Analisis AI

Kemungkinan Diagnosis:

Kemungkinan diagnosis utama adalah dermatitis atopik pada anak, didukung oleh gatal kronik-kambuhan >6 bulan, distribusi khas pada area fleksural (lipatan siku dan lutut), kulit sangat kering/bersisik, ekskoriiasi, serta riwayat atopi keluarga (ibu asma). Diagnosis banding yang perlu dipertimbangkan adalah dermatitis kontak alergik/iritan bila ada pajanan sabun/deterjen/pakaian tertentu, skabies bila gatal malam sangat dominan disertai lesi di sela jari atau anggota keluarga ikut gatal, dan impetiginisasi sekunder bila muncul krusta kuning, cairan, nyeri, atau pustul. Saat ini tidak ada data kuat yang mengarah ke infeksi sistemik atau kondisi gawat, namun perlu menilai ada tidaknya infeksi sekunder pada lesi garukan.

Kode ICD-10:

- L20.9 — Atopic dermatitis, unspecified
- L25.9 — Unspecified contact dermatitis
- B86 — Scabies
- L01.0 — Impetigo

Rekomendasi Terapi:

- Hydrocortisone topikal 1% krim/salep — oles tipis pada lesi di lipatan siku/lutut 2 kali sehari — selama 5-7 hari; bila peradangan sedang dan tidak membaik, dapat dipertimbangkan mometasone furoate 0,1% krim/salep atau triamcinolone acetonide 0,1% krim/salep — oles tipis 1 kali sehari — maksimal 5 hari pada area fleksural, lalu evaluasi. Hindari penggunaan jangka panjang tanpa kontrol dokter.
- Cetirizine sirup — 2,5 mg per oral 1 kali sehari malam hari — selama 5-7 hari untuk membantu mengurangi gatal, terutama bila mengganggu tidur. Hindari bila ada riwayat reaksi alergi terhadap obat ini.
- Emolien tebal tanpa pewangi (mis. petroleum jelly atau krim pelembap ceramide) — oles seluruh kulit kering minimal 3-4 kali sehari dan selalu dalam 3 menit setelah mandi — jangka panjang untuk memperbaiki skin barrier dan mencegah kekambuhan.
- Tindakan non-farmakologi: mandi singkat 5-10 menit dengan air suam-suam kuku, gunakan sabun syndet lembut tanpa pewangi hanya pada area kotor, pakaikan baju katun longgar, potong kuku anak, hindari garukan, keringat berlebih, debu, deterjen keras, dan produk berpewangi.
- Pemeriksaan penunjang yang disarankan: evaluasi klinis distribusi lesi seluruh tubuh dan tanda infeksi sekunder; bila ada kecurigaan infeksi bakteri dapat dipertimbangkan kultur swab lesi, dan bila diagnosis meragukan/rekuren berat dapat dipertimbangkan rujukan ke dokter spesialis kulit untuk penilaian dermatitis atopik dan pencetus.

Saran Pemeriksaan Lanjutan:

Pemeriksaan dermatologis menyeluruh seluruh tubuh — untuk menilai distribusi khas dermatitis atopik, derajat keparahan, serta mencari tanda skabies atau dermatitis kontak. Evaluasi tanda infeksi sekunder pada lesi (krusta madu, pustul, cairan, nyeri tekan) — karena ekskoriiasi berulang meningkatkan risiko impetiginisasi. Bila ada kecurigaan skabies, lakukan pemeriksaan lesi khas di sela jari, pergelangan tangan, aksila, genital, dan tanyakan kontak serumah yang gatal — untuk membedakan dari dermatitis atopik. Bila kasus sering kambuh/berat atau ada dugaan pencetus spesifik, pertimbangkan rujukan untuk uji alergi terarah sesuai indikasi klinis — bukan sebagai pemeriksaan rutin, tetapi untuk membantu identifikasi pencetus.

Tanda Bahaya / Indikasi Rujukan:

Rujuk segera bila muncul demam, lesi cepat meluas, kulit sangat nyeri, bengkak atau hangat, keluar nanah/cairan banyak, krusta kuning luas, anak tampak lemas atau dehidrasi, terdapat vesikel menyebar/erosi nyeri yang mencurigakan eczema herpeticum, atau gatal/ruam tidak terkendali hingga mengganggu makan dan tidur berat meski terapi awal sudah diberikan.

5. Analisis Foto / Temuan Fisik

Deskripsi Visual: Pada foto tampak banyak lesi kemerahan tersebar pada kulit, berupa papul dan plak eritematosa kecil hingga sedang, sebagian berbatas kurang tegas. Beberapa lesi tampak kering, kasar, bersisik halus, dan ada area yang terlihat seperti bekas garukan/iritasi. Kulit sekitar juga tampak cenderung kering. Tidak tampak jelas lepuh besar, nanah luas, atau luka dalam pada foto ini.

Kemungkinan Temuan: Temuan visual dan keluhan sangat sesuai dengan proses peradangan kulit yang sering mengenai area lipatan pada anak, dengan kemungkinan utama dermatitis atopik (eksim), terutama karena gatal hebat, memberat malam hari, lokasi di lipatan siku dan lutut, serta kulit kering-kasar-bersisik. Kemungkinan lain yang masih perlu dipertimbangkan adalah dermatitis kontak/iritan, reaksi gigitan serangga, atau infeksi kulit tertentu bila ada lesi melingkar khas, namun dari pola keluhan dan distribusi, eksem/dermatitis atopik lebih mendukung. Garukan berulang juga dapat menyebabkan lecet dan meningkatkan risiko infeksi sekunder pada kulit.

Rekomendasi: Disarankan pemeriksaan langsung oleh dokter anak atau dokter kulit untuk memastikan penyebab dan menilai derajat peradangan serta ada tidaknya infeksi sekunder. Karena gatal berat sampai mengganggu tidur dan ada luka garukan, evaluasi langsung cukup penting. Sementara, jaga kulit tetap lembap dengan pelembap tanpa pewangi, hindari sabun keras, pakaian kasar/panas, dan usahakan kuku anak pendek agar garukan tidak memperparah luka. Segera periksa lebih cepat bila muncul nanah, kerak kuning, bengkak, demam, nyeri, atau ruam cepat meluas.

Catatan: Analisis ini hanya berdasarkan foto biasa dan informasi keluhan, sehingga bersifat pendukung dan bukan diagnosis pasti. Penegakan diagnosis serta pengobatan yang tepat tetap memerlukan pemeriksaan langsung oleh dokter.

■■ DISCLAIMER: Hasil analisis ini hanya sebagai Clinical Decision Support System (CDSS). Keputusan medis, diagnosis akhir, dan resep obat mutlak merupakan tanggung jawab dokter pemeriksa. Sistem AI tidak menggantikan pemeriksaan langsung oleh tenaga medis yang kompeten.

Dicetak oleh: AI Doctor System | 18 June 2026, 11:16